



DIAGNOSTIC DES CANCERS

Pr. A . CHIROUF

Service d'Oncologie Médicale

CHU CONSTANTINE

Novembre 2025

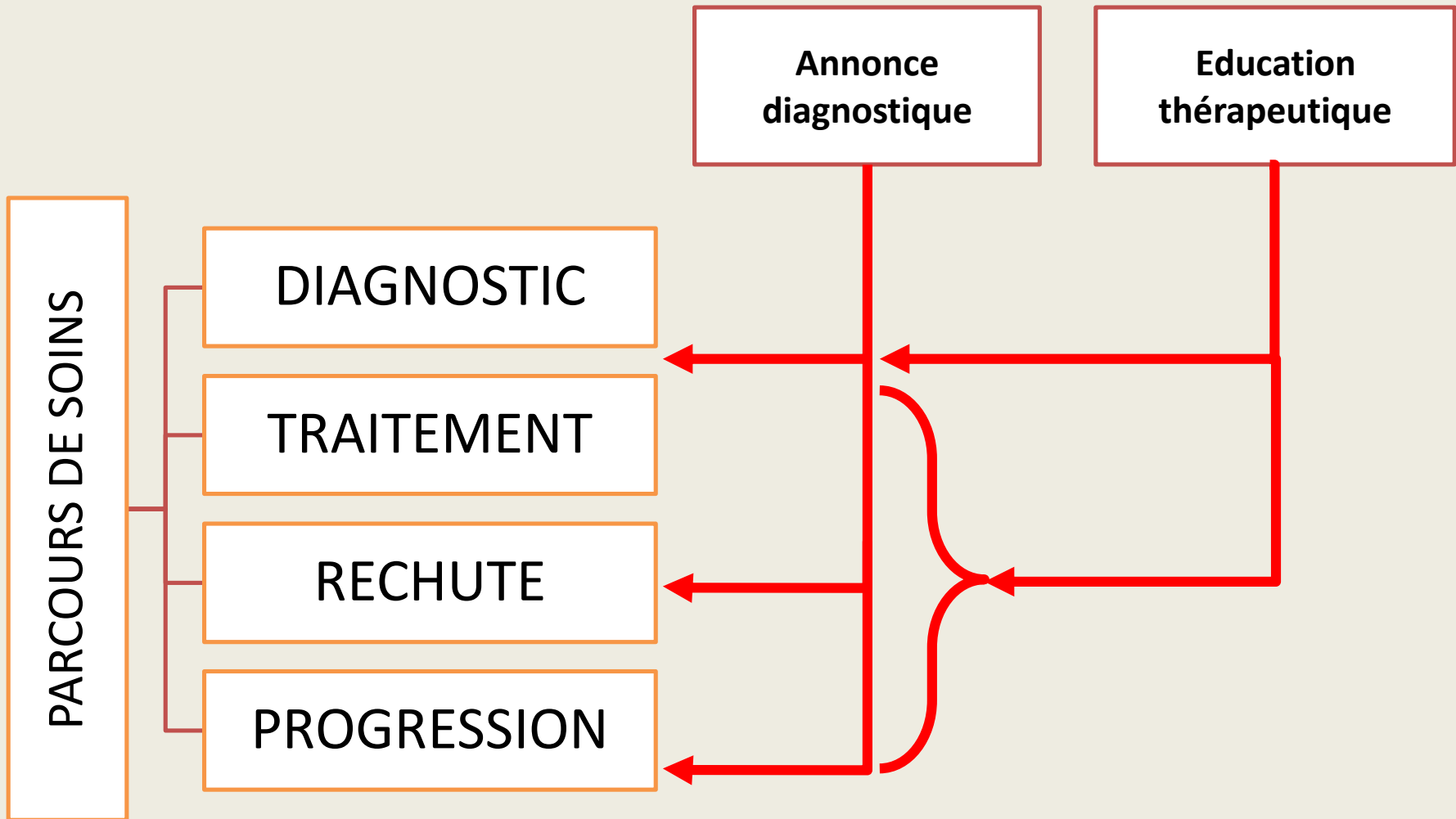
INTRODUCTION :

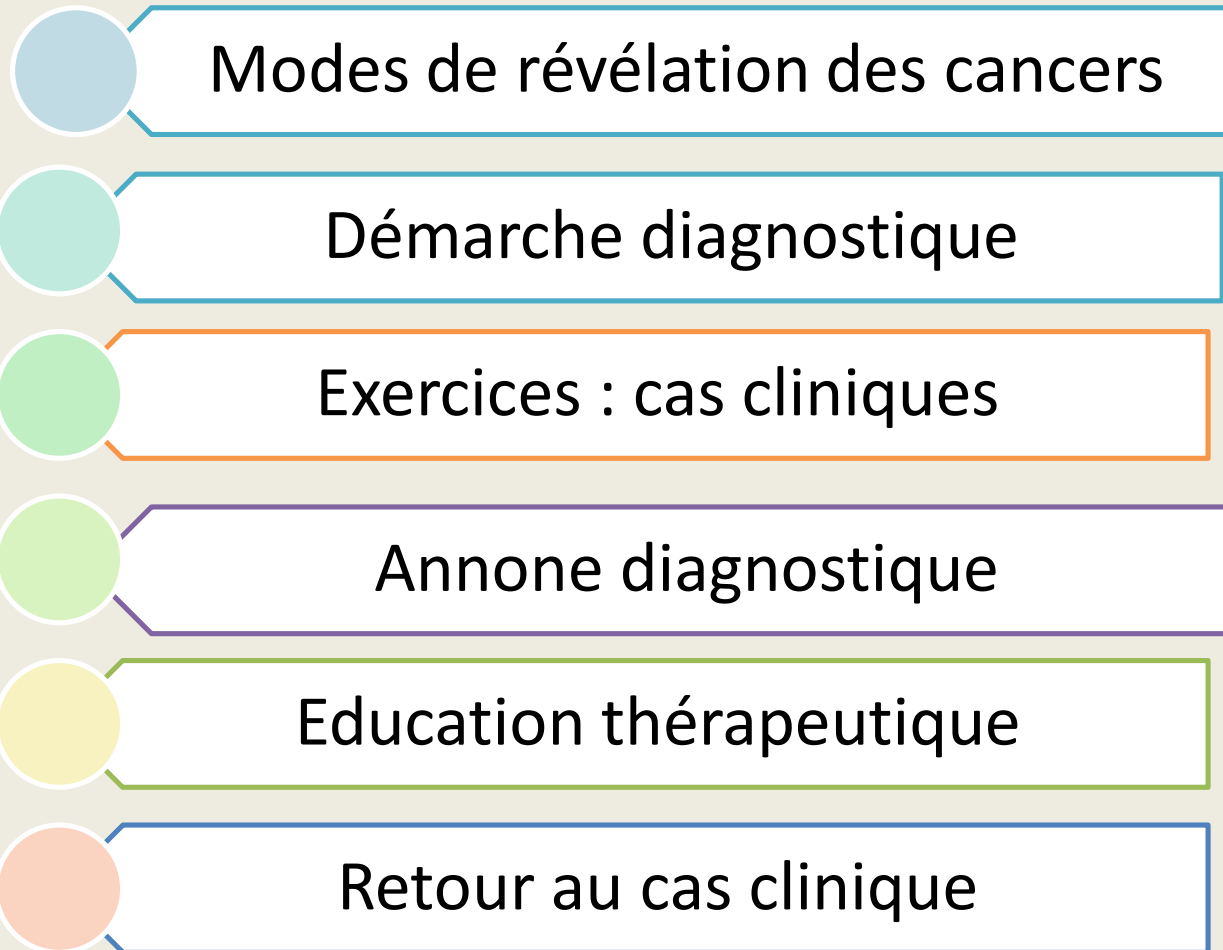
– 1- Définitions:

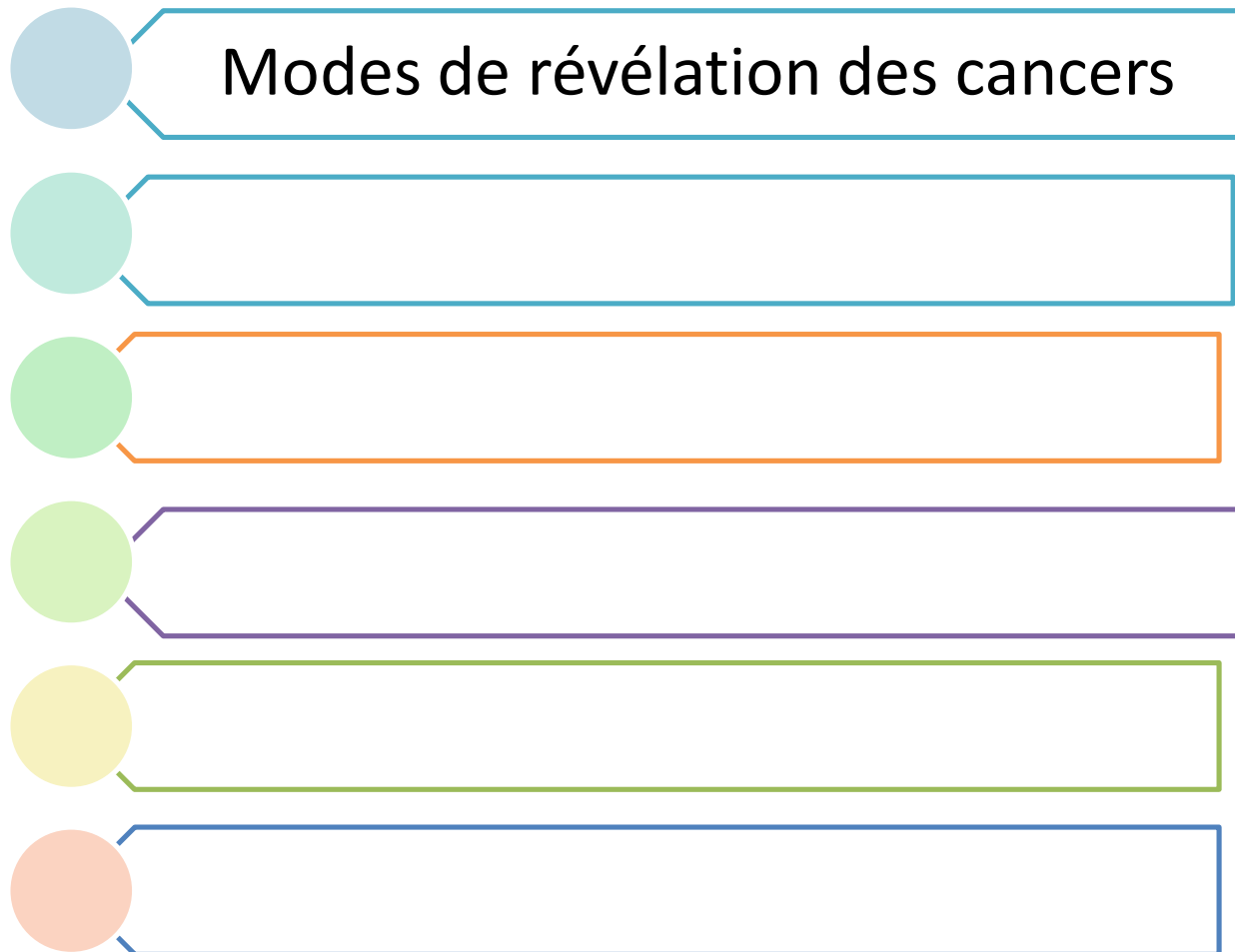
- Le diagnostic de cancer est établi devant un symptôme d'alerte,
- cette définition s'oppose à celle du dépistage ; où on recherche à découvrir une tumeur en absence de symptôme (surtout sujet à risque).
- démarche aboutissant à l'affirmation d'un cancer chez un patient consultant pour un symptôme.

- **2. Objectifs :**
- Arriver le plus rapidement possible au diagnostic.
- Connaissance histologique précise.
- Faire le bilan complet de la pathologie cancéreuse.
- Définir le stade du cancer que l'on va devoir traiter.
- Mettre en route un projet thérapeutique concerté

PARCOURS DE SOINS :

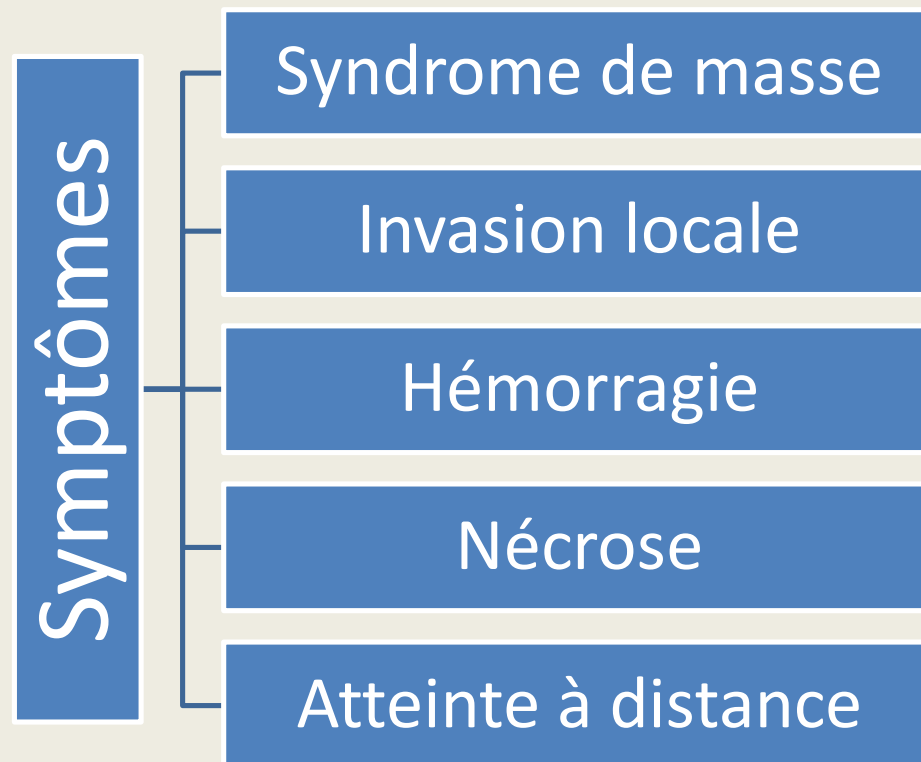






Modes de révélation des cancers

- Chaque localisation cancéreuse a son mode propre de révélation tumorale.



1. Syndrome de masse

Direct : La tumeur elle-même !

Le cancer envahit le tissu voisin : masse irrégulière et souvent dure.

Exemple : Nodule dans le sein

Indirect : Troubles provoqués par la présence de la tumeur : compression +++

Exemples :

- 1- Tumeur cérébrale et œdème cérébral consécutif ; des simples Céphalées au syndrome d'HIC (Hypertension Intra Crânienne) Céphalées, Vomissements, crises d'épilepsie), Troubles visuels.



1. Syndrome de masse

Indirect : Troubles provoqués par la présence de la tumeur : compression +++

Exemples :

- **2** : Dysphagie : si tumeur œsophagienne,
- **3** : Dysurie : compression urétérale et/ou urétrale par la tumeur prostatique.

2. Invasion Locale :

De l'organe atteint :

Perturbe l'aspect et la fonction :

- **Exemple aspect** : phénomène de peau d'orange : un cancer du sein qui envahit la peau,
- **Exemples fonction** :
 - dysphonie : atteinte des cordes vocales par un cancer du larynx,
 - dyspepsie des tumeurs gastriques,
 - constipation des tumeurs coliques.



2. Invasion Locale :

Le tissu environnant : provoquant

- œdème de compression (gros bras : cancer du sein, phlébite : tumeurs pelviennes)
- douleurs : atteinte des nerfs périphériques (Plexus coélique : cancer du pancréas, sciatiques : osseuses ou pelviennes)

3. Hémorragie :

Hémorragie

Nouveau Système de vascularisation pour nourrir : souvent fragile
!!!

- hémoptysie de la tumeur bronchique,
- hématémèse et méléna de la tumeur gastrique,
- hématurie des tumeurs vésicales, rénales,
- rectorragies des tumeurs rectales,
- métrorragies du cancer du col

Toute hémorragie mérite exploration, même en présence d'un traitement anticoagulant.

4. Nécrose :

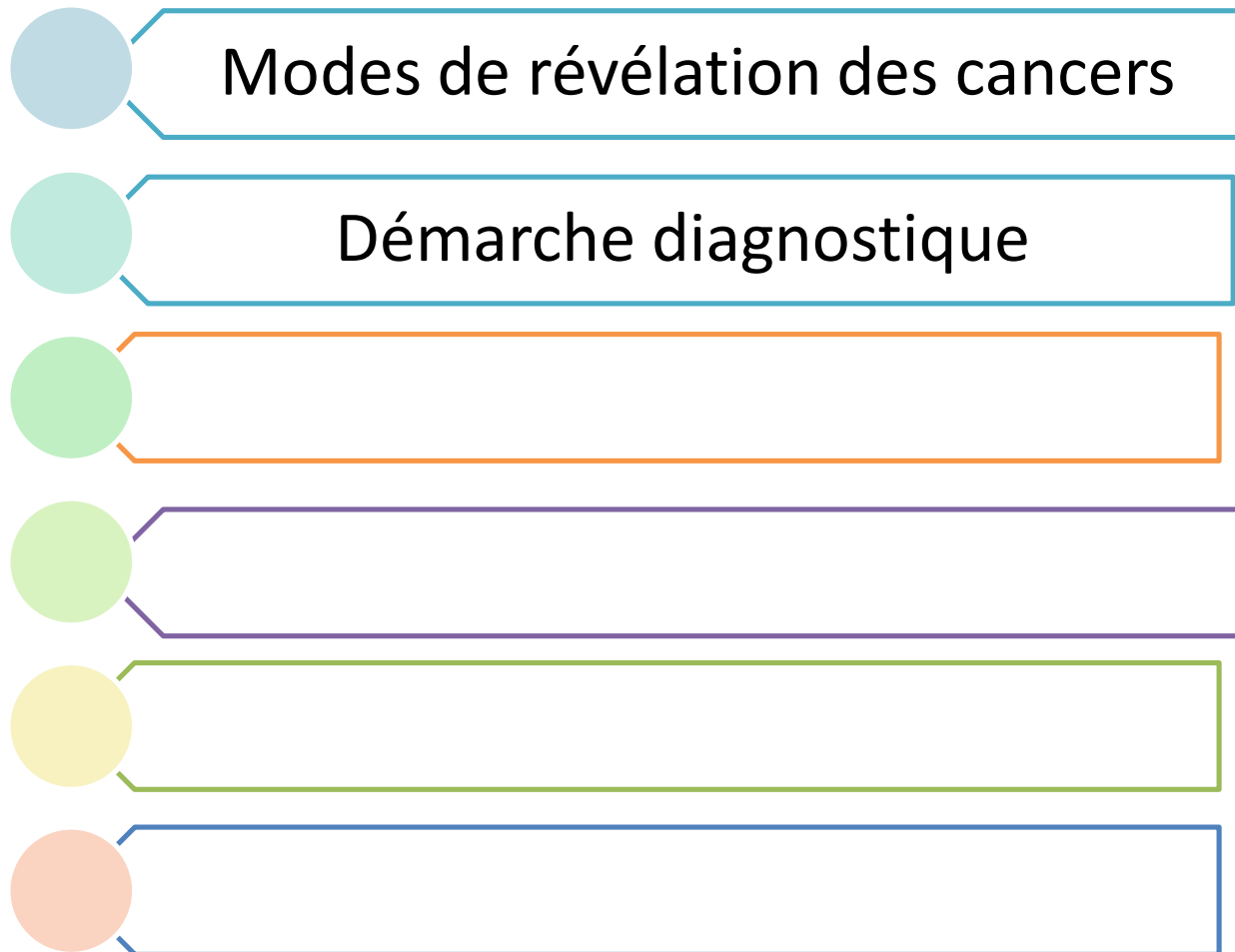
Conséquence de la mauvaise vascularisation tumorale.
Elle se complique fréquemment de :

- Difficultés de cicatrisation (ulcération cutanée sur cancer du sein).
- Surinfection : mauvaises odeurs très caractéristiques (tumeurs ORL, tumeurs génitales),
- Fistules : recto-vaginale, à la peau (cancer colique).

5. Evolution à distance :

La découverte du cancer par sa métastase survient dans 15% des cas

- ***Ganglionnaires*** :
 - ✓ ganglion sus-claviculaire de Troisier : tumeur digestive.
 - ✓ ganglion cervical : tumeur ORL,
- ***hépatiques*** (ictère, douleurs hépatiques),
- ***pulmonaires*** (dyspnée ou radiographie systématique),
- ***cérébrales*** (HIC, crise d'épilepsie...)
- ***Osseuses*** (douleurs, fracture pathologique).



Examen clinique :

1. L'interrogatoire : précis, discret :

Terrain (co-morbidités), les ATCDS P/F, la symptomatologie clinique et son évolution :

Caractéristiques Sémiologiques :

- Début : quand ?
- Evolution : continue, intermittent, aggravation...
- Facteurs déclenchant.
- Facteurs soulageant.
- Description : Type (douleur), couleur (écoulement),
- Quantifier : abondance (liquide), intensité (douleur), taille (nodule).

Examen clinique :

2. Examen clinique : détendu, complet, attentionné,

Inspection : changement V3, aspect, couleur, forme...

Palpation : masse palpable, ADP, HPM...

Percussion : matité (ascite)...

Auscultation : cardiovasculaire, poumon

Examen clinique :

Intérêt :

- Diagnostic et classification (exp kc du sein...)
- Orienter les examens complémentaires, expliquer le déroulement...

Examens biologiques :

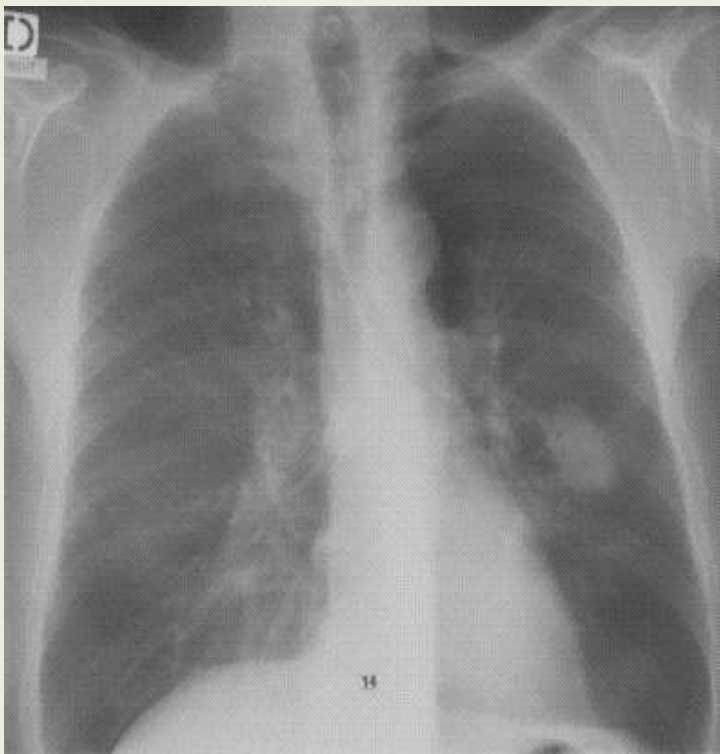
Intérêt :

- ✓ Diagnostic : exp FNS et leucémie, AFP et Kc du foie
- ✓ Extension : Calcémie (méta osseuses, TGO-TGP : méta hépatiques)
- ✓ Surveillance de l'efficacité des TRT (MT : PSA)
- ✓ Suivi de l'évolution de la maladie : MT CA15.3 et sein, CA125 et ovaire
- ✓ Dépistage d'une récurrence : MT ACE, CA19.9 et Kc colon

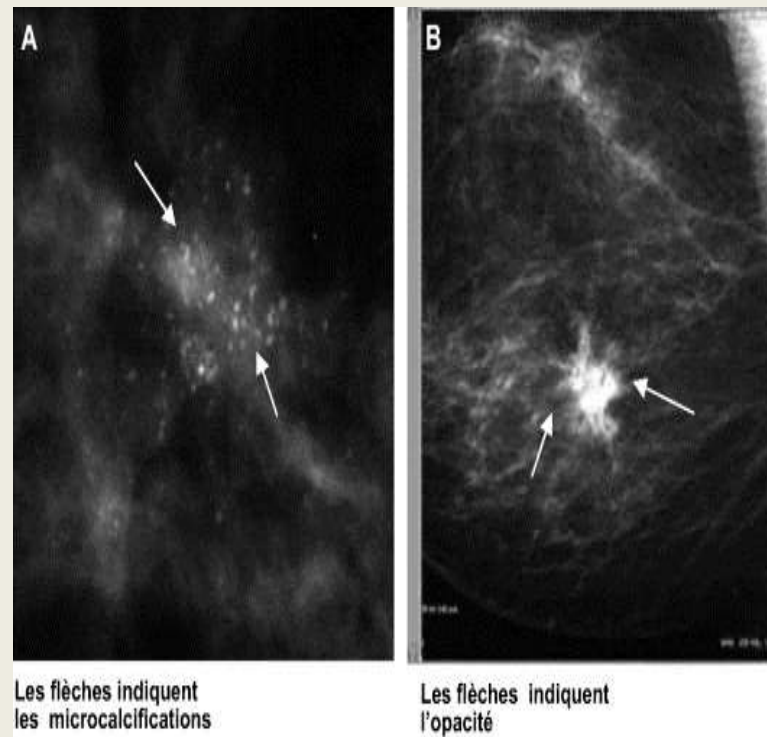
Examens radiologiques :

- RX Standard /la mammographie,
- le scanner , l'IRM,
- Echographie,
- Scintigraphie,
- PET scan
- Examens endoscopiques ; Exploration des organes creux :
 - ✓ Colonoscopie.
 - ✓ FOGD.
 - ✓ Hystéroskopie...
- **Intérêt:** Dg , Staging (bilan d'extension),décision TRT, geste TRT

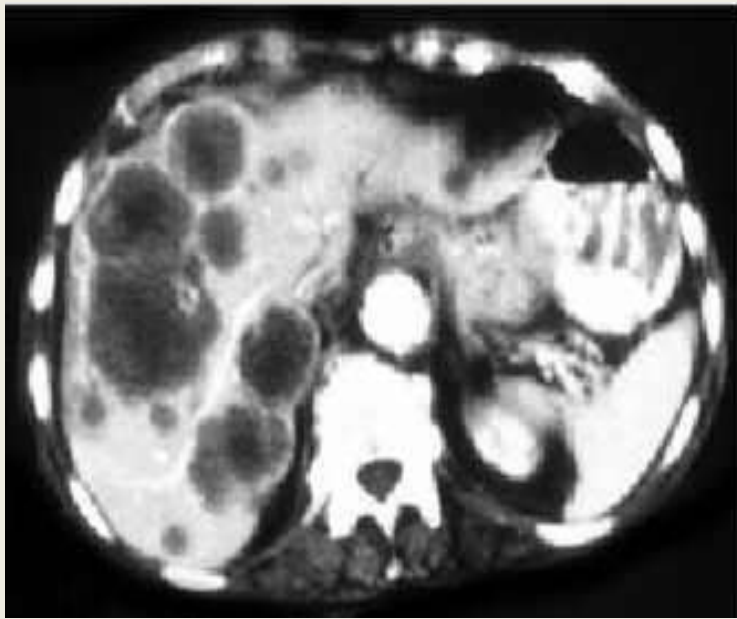
Examens radiologiques :



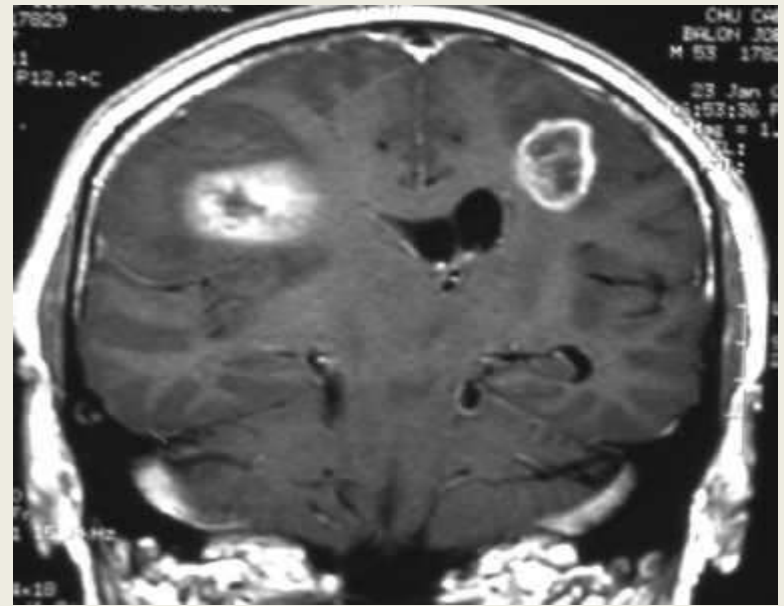
nodule solitaire du poumon



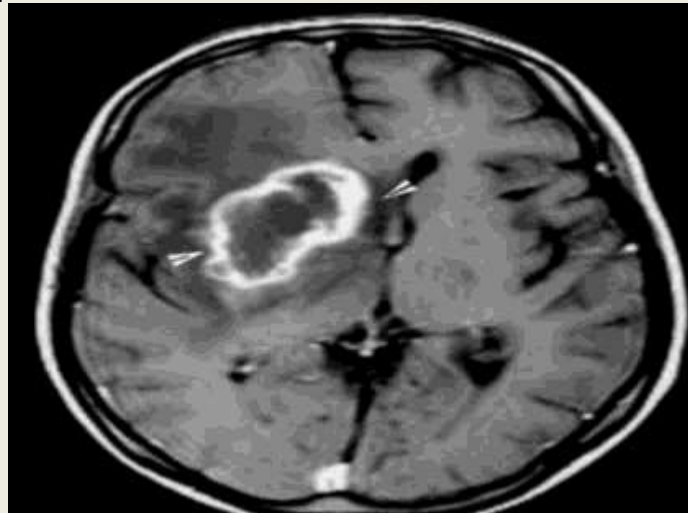
mammographie



scanner abdominal (foie - pancréas -
voies biliaires)



scanner de la tête et du cou



IRM Cérébrale

Diagnostic anatomopathologique :

- Le diagnostic de cancer exige **toujours** un **examen anatomopathologique (diagnostic de certitude)** :
- Biopsie, pièce opératoire,
- Décrire l'aspect macroscopique général,
- Confirmer la malignité de la tumeur,
- Le type histologique, le grade,

Bilan d'extension :

- Précise l'extension de la maladie à distance de l'organe d'origine.
- Choix selon le tropisme connu de la tumeur : recommandations.
 - Ganglionnaire.
 - Viscérale : foie, poumon, SNC.
 - Osseuse...
- Ces bilans se veulent raisonnablement complets, peu invasifs

Classification – stadification :

- Au terme de ce bilan local, régional et général on peut classer les tumeurs.
- Intérêts :
 - ✓ Langage commun pour l'extension de la maladie : échange d'informations entre équipes : RCP
 - ✓ Renseigne sur le pronostic.
 - ✓ Aide dans le choix thérapeutique

 - ✓ Comparer les résultats des TRT.
 - ✓ D'encourager les recherches sur le cancer.

Classification – stadification :

La classification TNM :

La plus utilisée, applicable a la majorité des tumeurs solides. UICC (union internationale contre le cancer).

Elle repose sur 03 éléments :

- T : extension de la Tm primitive.
- N : absence ou présence de métastases ganglionnaires régionales ou juxta régionales.
- M : absence ou présence de métastases a distance.

Chacun des éléments est affecté d un chiffre indiquant un volume Tm ou une gravité pc croissante.

Classification – stadification :

Stadification :

Stade I : atteinte localisée à l'organe, de petite taille.

Stade II : atteinte régionale limitée ou ganglionnaire limitée

Stade III : atteinte régionale avancée ou ganglionnaire avancée

Stade IV : atteinte à distance (métastases)

- Modes de révélation des cancers
- Démarche diagnostique
- Exercices : cas cliniques
-
-
-

CAS CLINIQUES

- Quel est votre démarche diagnostic?

**Cas 1: Homme de 60ans fumeur
vient consulter suite à une
hémoptysie**

Kc pulmonaire

**Cas 2: Femme de 45ans ménopausée
vient consulter suite à l'autopalpation
d'un nodule du sein gauche**

Kc du sein

**cas3: Femme de 65 ans se plaint d'une
douleur abdominale récurrente, des
épisodes de diarrhée, perte de poids de
5 kg**

Kc du colon

**Cas 4: Homme de 75 ans, PSA élevé
dans le cadre d'examen de dépistage**

Kc de la Prostate

cas1: KC BRONCHO-PULMONAIRE

1/Examen clinique:

Interrogatoire: FDR (tabac, profession, broncho-pneumopathie chronique), ATCDS, évolution des symptômes

Examen clinique : SF (respiratoires et EG 3A), SP souvent pauvre

2/Bilan diagnostique :

TDM thoracique, bronchoscopie,

Biopsie : étude anapath + IHC

3/Bilan d'extension : Scintigraphie osseuse, Echographie /TDM A/P (foie), Scanner Thoracique +/- TDM Cérébral (CPC)

4/Classification: TNM (Stade)

5/Bilan pré thérapeutique et TRT

cas2 : KC DU SEIN :

1/ clinique:

Interrogatoire : FDR (CO, nulliparité, Obésité), ATCDS P/F++, l'évolution

Examen clinique : Palpation des sein quadrant/quadrant + creux axillaire et sus clav. et général



2/Bilan diagnostique : mammographie + échographie mammaire, microbiopsie pour étude anapath et IHC



3/Bilan d'extension : Scintigraphie osseuse, TDM A/P (foie), TDM thoracique (poumon)



4/Classification: TNM (Stade)



5/Bilan prétherapeutique et TRT

Cas3 . Kc colique

1/Examen clinique :

Interrogatoire : FDR (PAF, obésité, RCH, apport calorique++, ATCDS P/F++, l'évolution des symptômes

Examen clinique : SF : troubles du transit, douleurs abdominales,SG



2/Bilan diagnostique : Colonoscopie, biopsie, étude anapath



3/Bilan d'extension :

TDM A/P (foie), TDM thoracique (poumon)



4/Classification: TNM (Stade)



5/Bilan préthérapeutique et TRT

cas4: KC DE LA PROSTATE

1/Examen clinique:

Interrogatoire: FDR, ATCDS P/F, l'évolution des symptômes

Examen clinique: TR, général



2/Bilan diagnostique : TR, Echographie endorectale, IRM prostatique, biopsie, étude anapath



3/Bilan d'extension :

TDM A/P (foie), TDM thoracique (poumon),
Scintigraphie osseuse



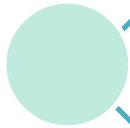
4/Classification: TNM (Stade)



5/Bilan préthérapeutique et TRT



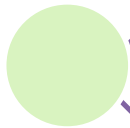
Modes de révélation des cancers



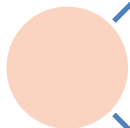
Démarche diagnostique



Exercices : cas cliniques



Annone diagnostique



Éléments à prendre en compte

Penser au projet de soins

Éléments de vie du patient

- Son histoire de vie (familiale, professionnelle).
- Antécédent(s) familial(aux).
- Ses antécédents.
- Difficultés expression et/ou compréhension.
- Contexte socioculturel et financier.

Ressenti et vécu antérieur

- Relation antérieure avec le patient,
- Sentiment de réussite ou d'échec.

Éléments liés à la maladie et au contexte

- Notion d'urgence.
- Stade évolutif de la maladie,
- Pronostic fonctionnel,
- Impact de la maladie sur le mode de vie
- Possibilités thérapeutiques

Avoir envisagé concrètement les possibilités thérapeutiques
Leurs impact sur le pronostic

Annnonce du diagnostic



Processus d'annonce

Points pouvant être abordés avec le patient

Aide au partage de l'annonce par le patient

- Faire l'annonce dans un lieu approprié,
- Important que le médecin soit disponible
- Lui proposer de compléter son information par des sources complémentaires
- Évoquer les aides possibles :

L'appréhension d'annoncer le diagnostic à son entourage, les moyens pour y parvenir :

- pourquoi le dire (oui ou non le dire) ;
- à qui le dire ;
- quand le dire ;
- comment le dire.

La question du secret médical

Processus d'annonce

- pour atténuer la brutalité de l'annonce, il est recommandé lors des tests diagnostiques d'expliquer la raison pour laquelle ils sont effectués.
- Savoir avant l'entretien que le résultat d'un test peut révéler un diagnostic de cancer diminue le choc de l'annonce.
- Ce premier entretien sera celui dont le patient se souviendra le mieux. Chaque phrase sera interprétée



Modes de révélation des cancers



Démarche diagnostique



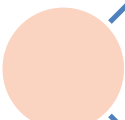
Exercices : cas cliniques



Annone diagnostique



Education thérapeutique



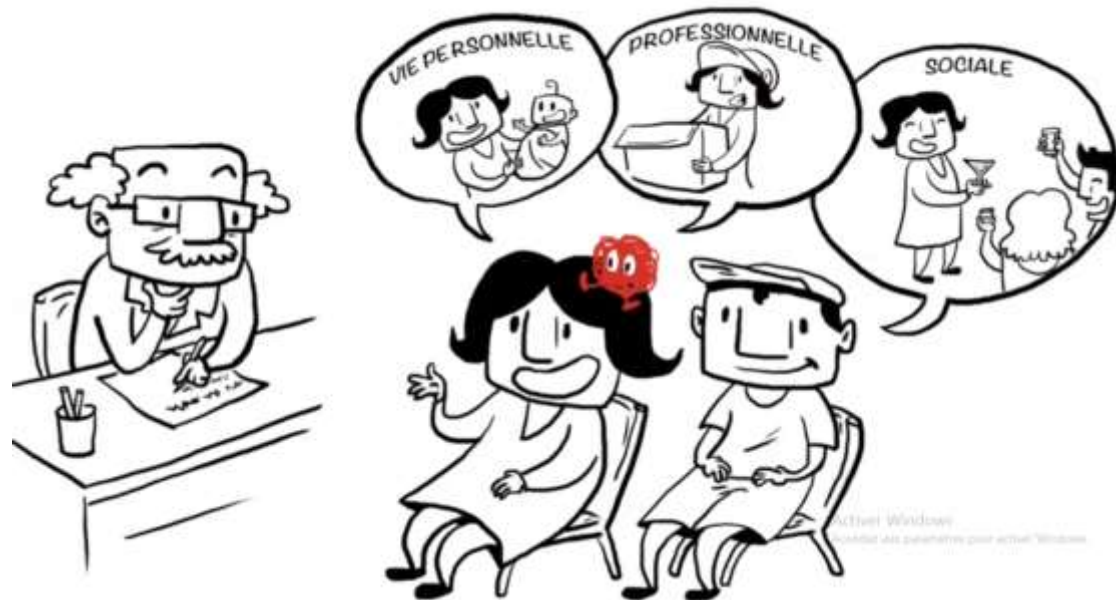
Définition de l'ETP :

OMS 1998 :

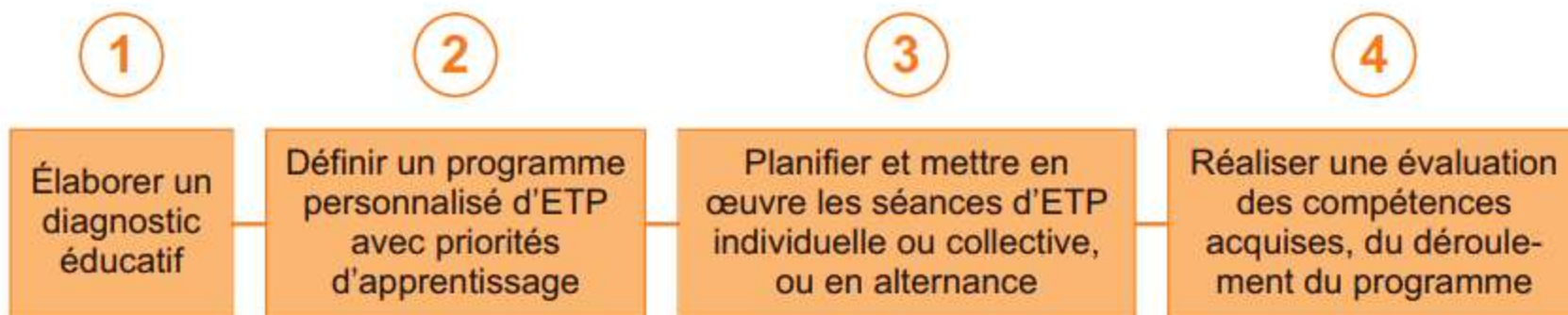
« L'ETP vise à aider les patients à **acquérir ou maintenir les compétences** dont ils ont besoin pour **gérer au mieux leur vie** avec une maladie chronique. »

- Maladie ?
- Traitements ?

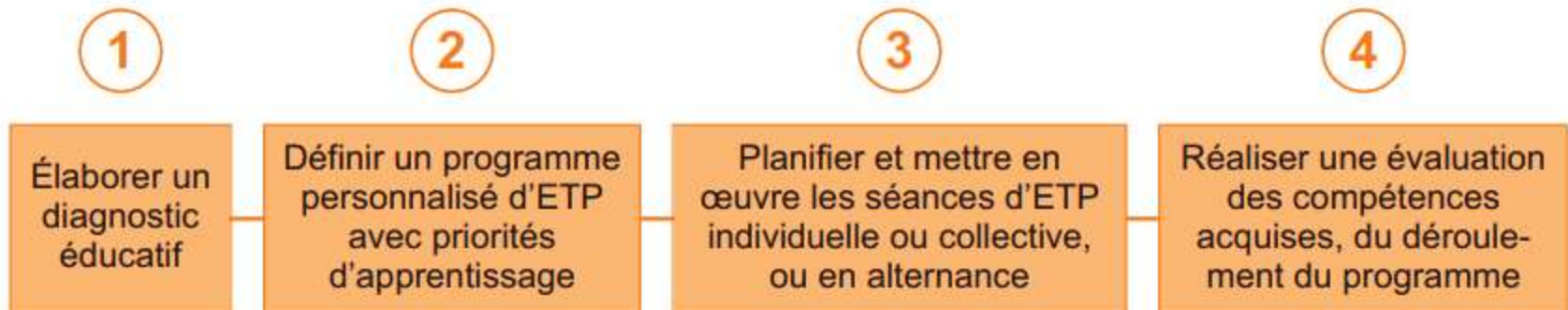
**Etre les principaux
Acteurs de leurs PEC**



Etapes de l'ETP :



Étapes de l'ETP :

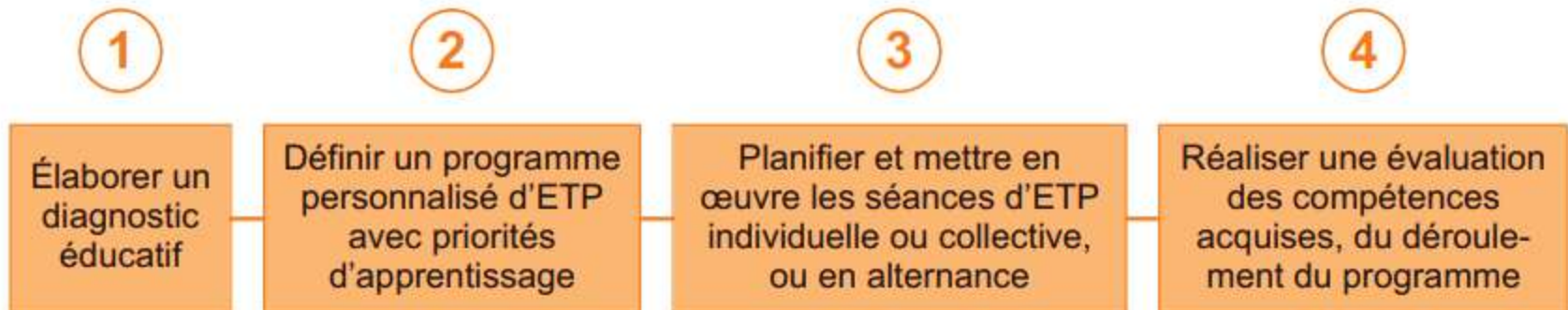


- Connaissance du patient,
- Identifier ses besoins et ses attentes
- Formuler les compétences à acquérir
- Priorités du patient.

Doit être actualisé régulièrement lors de la survenue de tout élément nouveau



Etapes de l'ETP :



Les compétences d'autosoins

- Soulager les symptômes.
- Prendre en compte les résultats d'une autosurveillance, d'une automesure adapter des doses de médicaments, initier un autotraitement.
- Réaliser des gestes techniques et des soins.
- Mettre en œuvre des modifications à son mode de vie (équilibre diététique, activité physique, etc.).
- Prévenir des complications évitables.
- Faire face aux problèmes occasionnés par la maladie.
- Impliquer son entourage dans la gestion de la maladie, des traitements et des répercussions qui en découlent.

Etapes de l'ETP :

1

Élaborer un diagnostic éducatif

2

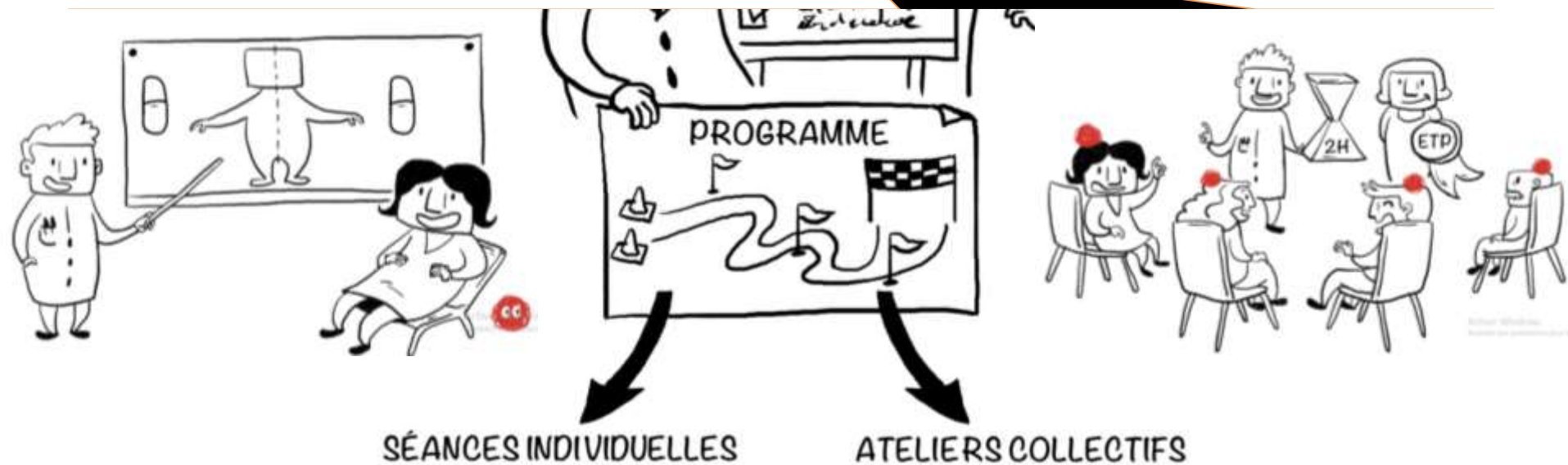
Définir un programme personnalisé d'ETP avec priorités d'apprentissage

3

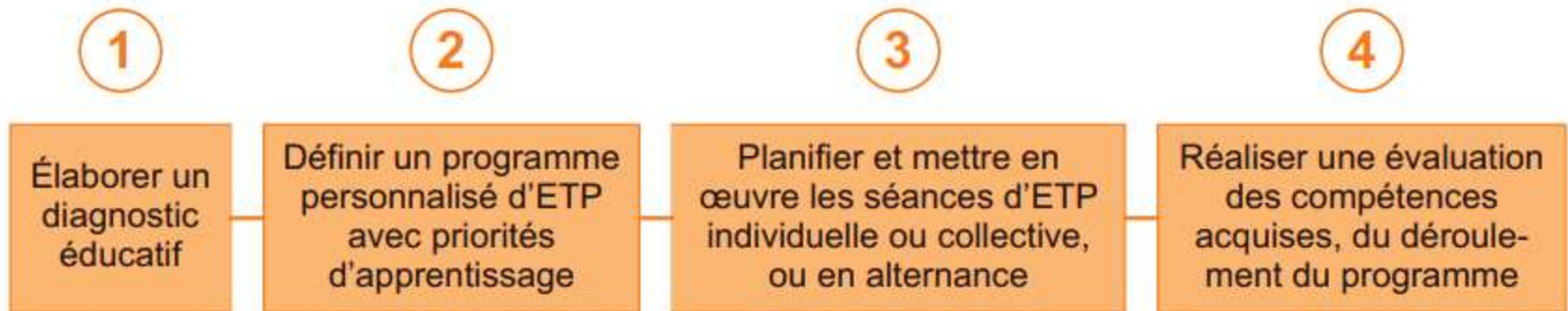
Planifier et mettre en œuvre les séances d'ETP individuelle ou collective, ou en alternance

4

Réaliser une évaluation des compétences acquises, du déroulement du programme



Etapes de l'ETP :



À quel moment?

au minimum à la fin de chaque offre d'ETP

à tout moment par le professionnel ou le patient la sollicite

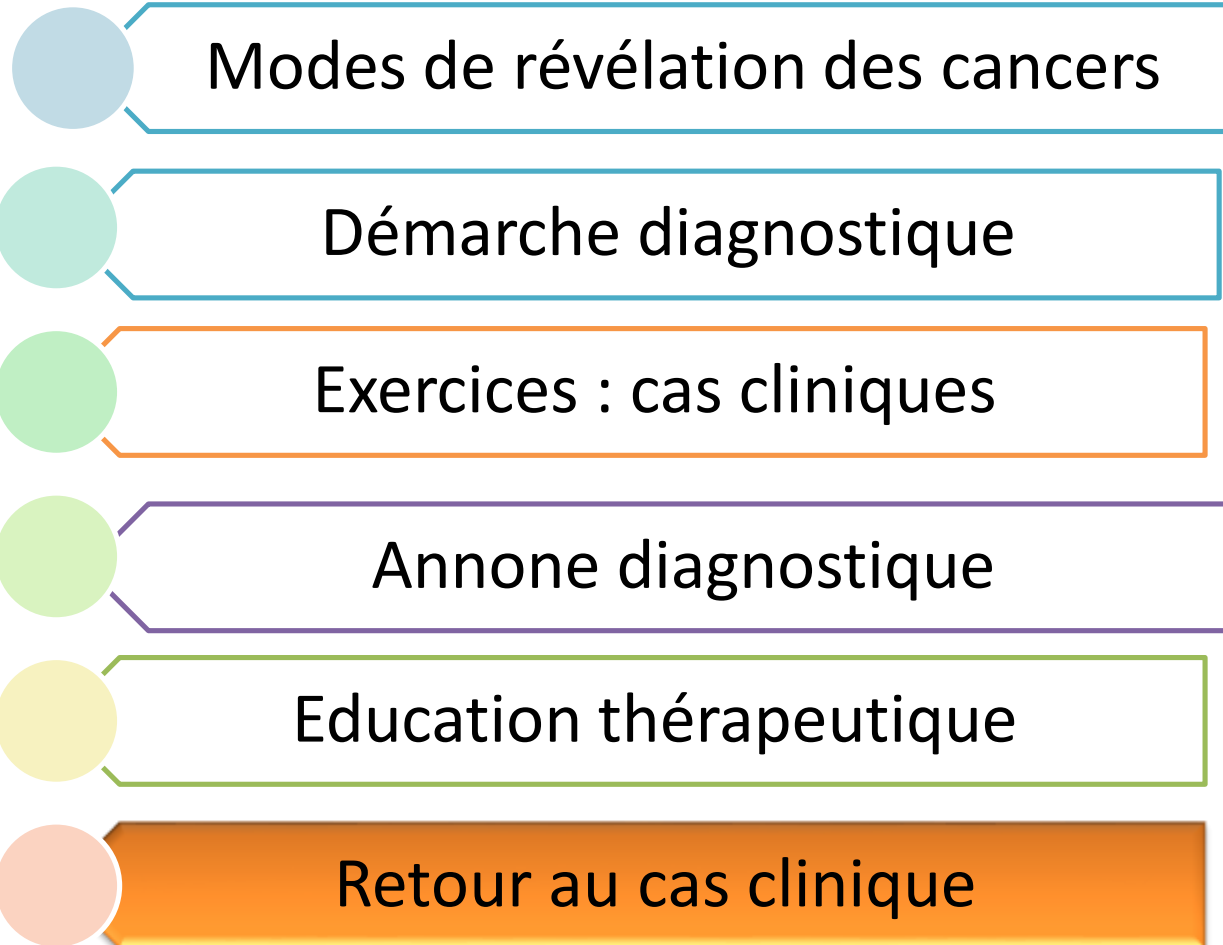
Quels sont les objectifs ?

mettre en valeur les transformations intervenues : acquisition de compétences, vécu de la maladie etc.

actualiser le diagnostic éducatif

proposer au patient une nouvelle offre d'éducation

thérapeutique

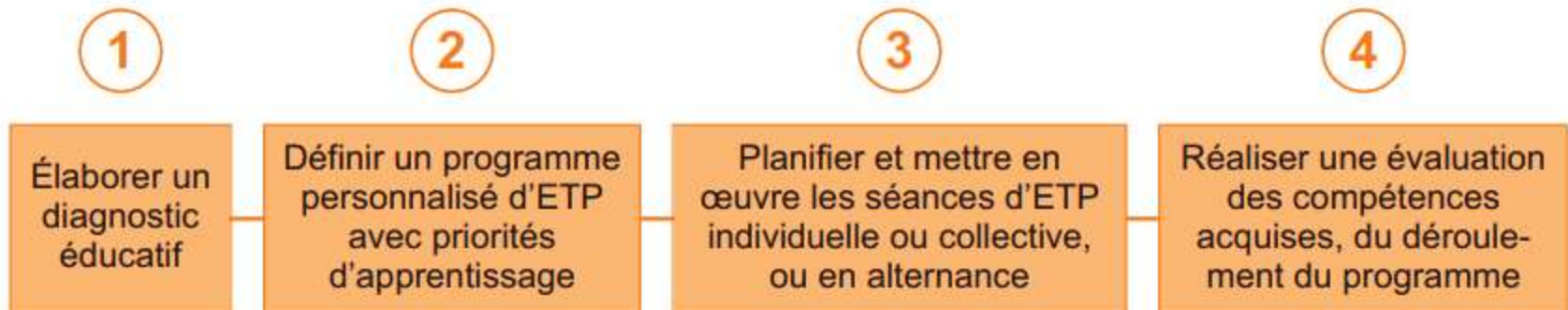


DISCUSSION 2

cas2 : KC DU SEIN :

**femme de 42 ans ménopausée vient consulter suite à
l'autopalpation d'un nodule du sein gauche chez qui
on suspecte un
Kc du sein**

Etapes de l'ETP :



Enfants en bas âge,
peu d'aide à leur PEC.

Optimiste pour l'évolution de sa maladie.

Comprend que les traitements seront lourds.

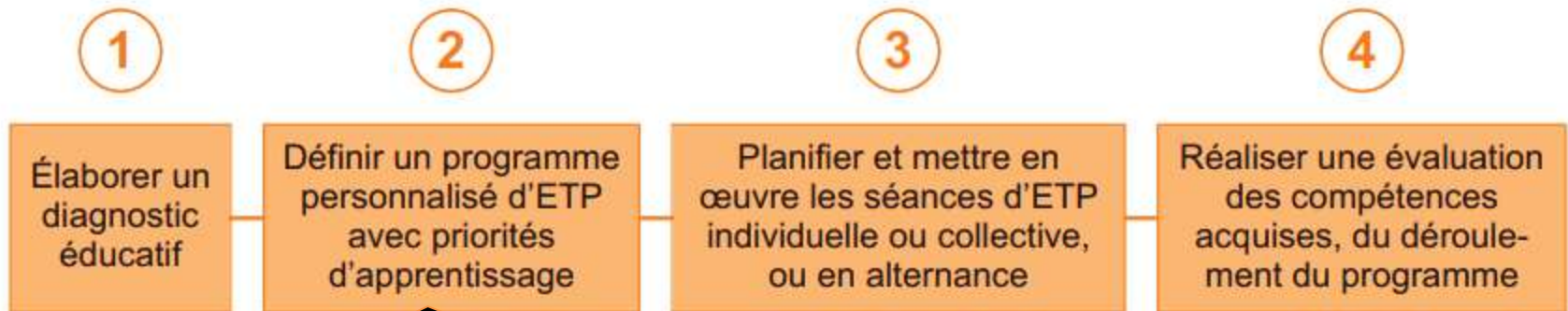
S'inquiète sur son état général et ses RESPONSABILITES

Priorités :

Prévenir les effets secondaires : vomissements +++

Garder la formes.

Etapes de l'ETP :



- Expliquer le parcours de soins personnel : nombre de cures, intervalle, durée, suites opératoires, séances de radiothérapie...
- Prémédication avant les cures : prévenir les réaction allergiques.
- Expliquer les effets secondaires possibles.
- Les médicaments à prendre pour prévenir les vomissements, comment réagir s'ils s'installent ? Quand consulter ?

CONCLUSION

- Le diagnostic du cancer est une étape importante du parcours.
- La connaissance des symptômes limite la perte de temps, rationalise les investigations.
- Le diagnostic de certitude est anatomopathologique, et le bilan d'extension est systématique.
- Ces informations sont nécessaires à l'annonce du Dc, la décision thérapeutique, et l'anticipation de l'ETP.